



医师法 与 医生权益

浙大二院

教学目标



目标1

简述《中华人民共和国医师法》关于医师权利、义务及法律责任的核心条款

目标2

用相关法律条款分析典型案例，对其合规性作出判断

目标3

评价医疗实践中如何在维护医生合法权益，并提出合理的实践建议

案例讨论1

医疗场所内的录音录像——信任危机还是维权工具

案例讨论2

公共场合急救——道德召唤下的法律风险

CCTV 13





课前学习回顾

- 《中华人民共和国医师法》
- 正式通过： 2021年8月20日，由第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议表决通过。
- 正式施行： 2022年3月1日。
- 请根据你对该法的理解，完成习题





思考

《中华人民共和国医师法》中与日常工作最相关的根本权益有哪些？





理解和善用这些权益，对医生的职业生涯至关重要

- ◎ 执业自主权——诊疗行为的专业保障
- ◎ 执业安全保障权——人格尊严与人身安全
- ◎ 风险免责权——紧急救助的“定心丸”
- ◎ 获得劳动报酬与休息权——职业生活的保障
- ◎ 参与民主管理与专业发展权——职业成长的路径

.....

医疗场所中的私自录音录像

患者不相信医生 怕误诊偷偷用手机录音



都挺好的, 没什么问题



讨论一：现象与认知—— 我们如何看待这一行为？



分组讨论

(分2组，每组4-5人，分别代表医生和患者)

每组学生开展讨论5分钟，并推荐1位代表发言



我们如何看待这一行为？

患方需求

- 信息留存与回顾
- 安全与证据保全
- 心理安全感与掌控感
- 寻求二次诊疗

医方顾虑

- 破坏信任基石
- 巨大的法律与职业风险
- 加剧防御性医疗
- 阻碍正常的医疗交流



讨论二：策略与应对—— 当我们面对时，该怎么办？

《诊室里的录音》

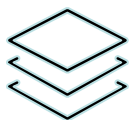
张医生在门诊接诊了一位冠心病患者的家属，正当他详细说明手术必要性和风险时，意外发现对方正在**偷偷录音**。他立即感到隐私与职业尊严被侵犯，情绪瞬间激动，当场质询患者家属。此举迅速引发**双方激烈争执**，张医生强调此种行为是对医患信任的严重破坏，并因此表示无法继续诊疗；患者家属则强烈不满，当场表示将投诉医生态度问题，最终双方沟通彻底破裂，不欢而散。





分组讨论

法律与权利：法律的边界在哪里？



- 聚焦《医师法》等法律法规，患者私自录音录像，侵犯了医师法哪些条款？
- 张医生最后“拒绝诊疗”的行为是否合法合规？在什么情况下医生可以中止诊疗？



策略优化：如何将“对抗”转化为“对话”？

讨论8分钟，每组推荐3名学生发言



患者私自录音录像，侵犯了医师法哪些条款？

◎ 《医师法》第四十九条：“禁止任何组织或者个人阻碍医师依法执业，干扰医师正常工作、生活；禁止通过侮辱、诽谤、威胁、殴打等方式侵犯医师的人格尊严、人身安全。”

◎ 法理剖析：

- 干扰正常工作：诊疗是一个需要高度专注的脑力劳动过程。当医师知晓或怀疑自己被私自录音录像时，会产生巨大的心理压力和防备心理，这无疑会**干扰**其正常的诊疗思维和决策过程。医师可能因担心言多必失或被断章取义，而不敢进行必要的病情探讨或告知，从而影响诊疗质量。
- 侵犯人格尊严：在未获同意的情况下进行录音录像，本身就是一种不尊重的行为。它单方面将医师置于被监督、被审查的境地，破坏了医患之间平等的、基于信任的关系，构成了对医师职业人格尊严的漠视。如果录制的音视频被恶意剪辑、歪曲并传播，则更构成了明确的“侮辱、诽谤”，直接违反本条。



患者私自录音录像，侵犯了医师法哪些条款？

◎ 《医师法》第二十三条： 医师在注册的执业范围内，依法进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案。

◎ 法理剖析：

- 私自录音录像带来的“**防御性医疗**”压力，实质上侵蚀了医师的执业自主权。为了规避风险，医师可能被迫放弃他认为对患者最有利但有一定风险的个性化治疗方案，转而选择最保守、最“无懈可击”的方案。这种行为外部压力导致医师无法完全依据医学专业知识和患者病情来“选择合理的医疗方案”，是对其法定执业自主权的间接干涉。



医师“拒绝诊疗”面临的法律风险

- ◎ 《医师法》第二十七条第一款：“对需要紧急救治的患者，医师应当采取紧急措施进行诊治，不得拒绝急救处置。”
- ◎ 《医师法》第二十七条第二款：“医师在诊疗活动中应当向患者说明病情、医疗措施和其他需要告知的事项。”
- ◎ 《医师法》第四十九条：“禁止任何组织或者个人阻碍医师依法执业，干扰医师正常工作、生活……”

“

破局策略：合理应对与智慧沟通



”



应对策略

- 一．保持冷静，专业判断
- 二．温和沟通，了解意图
- 三．明确告知，规范引导
 - 告知权利与边界
 - 引导规范的解决方案





小结：私自录音录像的法律应对与智慧沟通

- 法律定性：非“真空地带”，属“执业干扰”
 - 核心法条：《医师法》第49条
 - 私自录音录像构成对医师“正常工作”的干扰，侵犯其“人格尊严”。
 - 同时可能涉及《民法典》中关于隐私权与个人信息保护。
- 核心立场：有权维护权益，但不可“一拒了之”
 - 医师有权在不受干扰的环境下执业。
 - 但对于急危重症患者，直接拒绝诊疗违反《医师法》第27条，存在法律风险。正确的做法是规范交接或转诊。
- 破局之道：从“对抗”走向“疏导”，化“危机”为“契机”
- 职业素养：以规范书写病历为基础，以重建信任为目标

案例讨论1

医疗场所内的录音录像——信任危机还是维权工具

案例讨论2

公共场合急救——道德召唤下的法律风险



公共场合急救—你会出手相助吗？

案例一：高铁上救人反被索要医师证 & 记录仪（2019年）

事件回顾：

2019年3月，一名陈姓女医师在乘坐高铁时，听到广播求助后有乘客突发疾病，她立即前往施救。患者情况稳定后，高铁工作人员却上前询问她的医师证，并要求她写下情况说明，签字画押，并留下联系方式。更引发争议的是，工作人员还全程录像，其行为让陈医生感觉像是被“揪住”，害怕被讹诈，心情变得很低落。



讨论一：医生是否有公共场合 实施急救的义务

- 法律角度
- 职业道德角度

讨论一：医生是否有公共场合实施急救的义务



法律角度：受保护的义务，而非强制的责任

从法律上讲，中国法律**鼓励并保护**医生在公共场合实施急救，但通常**不将其规定为一项必须履行的强制性法定义务**。

➤ 《中华人民共和国民法典》—— “好人法” 条款提供免责保护

核心法条：《民法典》第一百八十四条规定：“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。”

➤ 《中华人民共和国医师法》—— 执业地点外的法定义务

核心法条：《医师法》第二十七条第三款规定：“国家**鼓励**医师积极参与公共交通工具等公共场所的急救服务；医师因自愿实施急救造成受助人损害的，不承担民事责任。”

讨论一：医生是否有公共场合实施急救的义务



职业道德角度：崇高的职业召唤与内在要求

- 职业誓言与宗旨的驱动
- 专业知识与技能赋予的特殊责任
- 社会期望与职业荣誉的体现
- 对“不作为”的自我谴责风险



讨论一：医生是否有公共场所实施急救的义务

核心法律依据——《中华人民共和国医师法》第三章第二十七条

- ✓ 对需要紧急救治的患者，医师应当采取紧急措施进行诊治，不得拒绝急救处置。
- ✓ 因抢救生命垂危的患者等紧急情况，不能取得患者或者其近亲属意见的，经**医疗机构负责人或者授权的负责人**批准，可以立即实施相应的医疗措施。
- ✓ 国家**鼓励**医师积极参与公共交通工具等公共场所的急救服务；医师因自愿实施急救造成受助人损害的，不承担民事责任。



案例一热议焦点

- ✓ 寒心与尊重：公众热议的焦点在于，对施救者缺乏信任和尊重的程序，是否会“寒”了好心人的心？以后谁还敢救人？
- ✓ 程序与善意：铁路方面后来解释，此举是“留存证据、避免纠纷”的程序性要求。但公众质疑，程序的执行方式是否过于僵硬、缺乏温度，将施救者置于潜在被告的境地？
- ✓ 法律保障缺失：当时旧版《执业医师法》并未明确针对院外施救的免责条款，医师的权益保障主要依赖道德舆论，缺乏坚实的法律后盾。

该事件在社交媒体上引爆，绝大多数网友力挺陈医生，谴责铁路方面的做法。它极大地推动了公众和立法者对于“保护施救者”的共识，为《医师法》修订中加入明确的免责条款提供了强大的民意基础。



讨论二： 医生是在公共场合实施急救如何保护自身的权利



如何具体操作以保障权益？

一、施救前：评估与准备

1. 明确身份，表明意愿。
2. 获取同意（如条件允许）：
如果患者意识清醒，应寻求其同意。简单的“我需要帮你看一下，可以吗？”即可。
如果患者无意识，法律上适用“默示同意”或“紧急无因管理”原则，即法律推定一个理性的人在清醒时是会同意接受急救的。您的施救行为符合公序良俗，受法律保护。

二、施救中：规范与记录

1. 遵循规范，量力而行。
2. 寻求见证，保留证据：
最好能有一两个旁观者作为证人，并留下他们的联系方式。
3. 及时交接：
一旦120急救人员到达现场，清晰、简洁地向专业人员交代病情、您采取的措施以及患者的反应。完成交接后，您的责任就基本结束了。

三、施救后：跟进与免责

1. 《医师法》第二十七条是“护身符”：
如果事后不幸遇到家属质疑或纠缠，您可以明确告知其《医师法》第二十七条关于“不承担民事责任”的规定。
2. 联系所在单位：
如果事件引发关注或纠纷，应立即向您所在医院的医务科或法务部门报告。
3. 心理支持：
无论结果如何，参与抢救后都会有心理压力。及时与同事、朋友或专业的心理辅导人员交流。

紧急寻医！浙大医学生在列车上发起“远程会诊”

人民日报健康客户端 记者 周学津 浙大一院 王蕊 江晨 2024-07-24 13:58

连日来，浙江大学医学院附属第一医院研究生社会实践团师生合力救助伤者，在列车上发起“远程会诊”的故事引发网友点赞。7月23日，浙江大学内科学博士研究生王威和施梦莎向人民日报健康客户端记者回忆起救助细节。

“旅客朋友们，列车紧急寻医，请从事医务工作的旅客前往5号车厢！”7月14日，在贵州遵义开往贵阳的D8585次列车上，列车广播的紧急呼叫引起浙大一院社会实践团师生的注意。

“听到广播，大家在群里响应很积极，都想尽一份力。”由于连挂车厢不通，和带队的实践指导老师浙大一院教学部杨晓龙和陈华瑞老师简单沟通后，距离5号车厢最近的博士研究生王威和施梦莎率先抵达事发车厢，为伤者评估病情。



“一到车厢，我们就看到乘务员、不少乘客都围在一位面色痛苦的阿姨身边，我和师妹挤进人群，表明身份后，就对阿姨进行了简单的病史询问和查体。”王威和施梦莎为伤者检查身体发现，这位60多岁的女士左下肢强迫体位，膝关节处有明显凹陷，口述膝盖处疼痛明显，下肢无法活动。同时，陈华瑞老师也抵达现场，为伤者家属和乘务人员介绍了两位同学的具体情况，做好伤者安抚，帮助维持现场秩序。

由于两位同学并非骨科专业，在安抚好受伤女士后，他们便连线了医院的骨科师友，进行了一场特殊的“远程会诊”。“当时已经是夜里11点多，我把情况简单说明以后，他们迅速回复了我，并通过视频电话初步判断阿姨可能出现了髌骨脱位。”王威告诉记者，经过讨论，决定为伤者做简单固定，不贸然复位，因为列车马上要抵达贵阳站，能够迅速接受进一步的医疗救治。

方案确定后，王威和施梦莎心里有了底，可却又犯了难。受制于列车上的治疗条件，并没有可供伤者用来固定伤处的夹板。“就在我们着急的时候，有乘客掏出了随身携带的衣物，还有乘客掏出了雨伞，还有同列车厢中的大学生拿出了自己的毕业学位证书外壳。”王威说，“那一瞬间，你能感受到一种互相信任、携手前进的力量感！”

虽然大家很热情，但是手头上的东西依然不能起到较好的固定作用。这时，王威灵机一动，在车厢内寻找废弃不用的纸板箱，同施梦莎一同使用鞋带、衣物对患者伤处进行固定，并完成了简易的固定制动。他们嘱咐这位受伤女士及家属，务必保持患肢静止，直至列车抵达下一站，即刻转往医院急诊处理。

“做好固定的那一刻，受伤女士及家属对我们表达了深深的谢意，我们也感受到什么是健康所系，性命相托。我想不管过去多久，这都是一段让我们难忘的记忆。”王威说。



小结

- 《中华人民共和国医师法》鼓励医生在公共场合实施急救
- 如结果不佳无需承担民事责任
- 医生在急救过程中需量力而行

教学目标



目标1

简述《中华人民共和国医师法》关于医师权利、义务及法律责任的核心条款。

目标2

用相关法律条款分析典型案例，对其合规性作出判断

目标3

评价医疗实践中如何在维护医生合法权益，并提出合理的实践建议

课后作业



- **课后反馈：**请扫描二维码，完成tutorial反馈，请留下宝贵的意见和建议



- **撰写反思：**结合相关课堂内容和其他学习资料，**记录你对现今医疗形式下，如何保障医生权益的思考**，字数200-500字，在课程结束3天内发至邮箱wulingyan@zju.edu.cn
(邮件请用名字+学号+题目命名)



谢谢!

授课人: XXX